Enseignement de la 3ème année médecine

Unité d'Enseignement Intégrée 2

Matière : la Sémiologie

Sémiologie Neurologique

Les troubles de la conscience : la lipothymie, la syncope, l'épilepsie

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit être capable de :

1. Définir une syncope.
2. Préciser les caractères sémiologiques d'une syncope*.
3. Citer les causes cardiaques et extra cardiaques d'une syncope.
4. Distinguer une syncope d'une lipothymie*.
5. Définir une épilepsie.

1/ Introduction :

Les troubles de la conscience peuvent être divisés suivant leur durée en Troubles de la conscience de durée brève ou pertes de connaissance brèves qui sont les plus fréquents : la Lipothymie, la Syncope et l'épilepsie et les trouble de la conscience de durée prolongée : Les comas, l'obnubilation et la confusion mentale.

2/ LES PERTES DE CONNAISSANCE BRÈVES

2.1. Les syncopes

2.1.1. Définition :

La syncope est une perte complète de la conscience brusque et passagère, liée à une anoxie cérébrale.

2.1.2. Etude sémiologique :

La syncope est un accident subit, s'accompagne d'une chute sur le sol. Elle est parfois précédée de prodromes tel que le Malaise avec pâleur, les sueurs, la nausée et les Troubles sensoriels. La perte de conscience est totale.

L'examen clinique retrouve une pâleur extrême du visage, une disparition du pouls et des battements cardiaques, La tension artérielle est imprenable et parfois on note un arrêt respiratoire ou une respiration stertoreuse.

La durée de la syncope est courte, de quelques secondes : 10 secondes en moyenne;

Si elle se prolonge au-delà de 10 secondes, elle se complique de convulsions, le malade présente alors un spasme tonique parfois suivi d'une ou deux secousses cloniques. La durée maximale est d'une minute.

Si cette durée est supérieure à trois minutes, Il s'ensuit la mort cérébrale.

A la fin de la syncope, la récupération de la conscience est immédiate et totale.

Chez tout malade ayant présenté une syncope, on devra systématiquement : ausculter le cœur à la recherche d'un souffle, vérifier la fréquence cardiaque, mesurer la tension artérielle en position couchée et en position debout, et faire un ECG.

2.1.3. Causes :

Les causes de syncope sont Cardiaques et extra-cardiaques

Causes cardiaques :

- **La syncope du syndrome d'Adams-Stokes :**
  Elle survient spontanément surprenant le sujet aussi bien en pleine activité qu'au repos complet, elle est en rapport avec un bloc auriculo-ventriculaire complet
- **La syncope d'effort** : survient à la marche rapide ou lors de la montée des escaliers, elle se voit essentiellement au cours du rétrécissement aortique.
- **Autres cardiopathies** :
  - **Chez l'enfant** : La tétralogie de Fallot
  - **Chez l'adulte** : La cardiomyopathie obstructive.

Les causes extra-cardiaques :

- **L'hypotension orthostatique idiopathique** : sans cause évidente
- **L'hypotension orthostatique iatrogène** : due à l'administration d'un médicament, le plus souvent traitement hypotenseur
- **L'hyper-réflectivité du sinus carotidien** : elle est provoquée par une pression externe du sinus carotidien ; elle réalise une syncope brusque et brève durant quelques secondes. Elle peut être provoquée sur le malade couché par une pression douée de la bifurcation carotidienne.

Les fausses syncopes :

- **Les syncopes vaso-vagales « syncopes réflexes »**, elles sont déclenchées par une peur, une prise de sang, un traumatisme épigastrique. Le déroulement est tout à fait superposable à celui de la lipothymie.

2.2. Les lipothymies

2.2.1. Définition :

La lipothymie est une perte incomplète de la conscience. Il s'agit d'une simple obnubilation en rapport avec une hypoxie cérébrale. Le terme populaire : «évanouissement »

2.2.2. Etude sémiologique :

Le mode de début de la lipothymie est progressif, il est marqué par une angoisse, des sueurs froides, des troubles sensoriels type bourdonnements d'oreille, impression de voile blanc devant les yeux, Sensation d'éblouissement et Sensation d'étourdissement. Puis, la station debout devient impossible avec chute sur le sol qui peut être évitée par un décubitus préalable.

La perte de connaissance n'est pas totale. Les signes accompagnateurs sont une pâleur du visage, une tension artérielle basse, un pouls petit mais qui reste perceptible.

La conscience revient lentement au bout de 2 à 3 minutes. La récupération physique est plus lente : en 15 à 30 minutes. Elle est suivie d'une sensation de fatigue.

2.2.3. Les Causes :

- L'hypotension orthostatique
- Le sujet neurotonique hyperémotif.

2.3. L'épilepsie ou perte de connaissance épileptique.

2.3.1. Définition :

L'épilepsie est une crise cérébrale en rapport avec une décharge paroxystique, hypersynchrone d'une population neuronale. Elle peut revêtir deux tableaux cliniques distincts :

- La crise de grand mal
- La crise de petit mal.

2.3.2. Etude sémiologique :

2.3.2.1. La crise de grand mal :

Elle survient à tout âge. Le mode de début est brutal, il s'agit d'une perte de connaissance brutale, inopinée et soudaine, sans prodromes entraînant la chute du malade.

La crise évolue en quatre phases : La phase tonique, La phase clonique, La phase stertoreuse, la phase résolutive.

La phase tonique :

Elle est marquée par une hypertonie généralisée avec apnée, cyanose et morsure de la langue. Sa durée est de 10 à 20 secondes.

La phase clonique :

Elle est faite de secousses musculaires violentes et synchrones. Elle s'accompagnant d'un relâchement sphinctérien avec perte des urines. Sa durée est de 30 secondes ;

La phase stertoreuse :

Pendant laquelle le malade présente une respiration ample et bruyante dite stertoreuse. Sa durée est de 30 secondes à 2 minutes.

La phase résolutive :

Au cours de laquelle on observe un retour progressif de la conscience. Cette phase est suivie d'un repos réparateur. Sa durée est de 10 minutes.

Après la crise, le sujet présente un signe important « ***amnésie postcritique »*** : Le patient ne se souvient pas de sa crise.

Si l'on n'a pas assisté à la crise, deux signes objectifs importants permettront de l'identifier

- **La morsure de la langue**
- **La perte des urines.**

2.3.2.2. La crise de petit mal ou absence :

Elle ne se voit que chez l'enfant. Elle réalise une suspension brève de la conscience. Sa durée est de 5 à 10 secondes. Elle est d'apparition soudaine et inopinée, sans prodromes. Elle ne s'accompagne ni de chute, ni de troubles du tonus, ni de relâchement sphinctérien, ni de manifestations cloniques.

Elle est suivie d'une reprise immédiate de l'activité.

Références :

- Rose marie HAMLADJI. Précis de sémiologie.